

またま生後4〜5カ月のときに、きょうだいの誰かがはしかをやつて、軽い感染をすませた人だ。母親からもらった抗体がほどほどに残っていて、外に症状のでない程度の軽いはしかにかかって免疫だけが残ったのだ。症状がでないで、母親もこの子にはしかなしていいと信じている。こういう人は妊娠初期に、はしかの子どもと接触してもうつらない。はしかに免疫のない妊婦が初期にはしかにかかると、ウイルスによつておかされた胎児は奇形がひどくて、流産してしまうのがおおい。

水痘に妊娠20週以内にかかると、赤ちゃんの2%に奇形がみられたという報告がある。水痘にかかったことのない妊婦が水痘の子に接したらすぐにガンマ・グロブリンを注射する。出産直前直後に母親が水痘になると生まれた子は重い水痘になる。

流感または**かぜ**は流行のあとに奇形がたくさんでたという話をきかないから、大丈夫なのだろう。流行時に初期の妊婦から何度も質問をうけたが、そういう人に生まれた子が奇形であったことはなかった。おたふくかぜにかかった母親が流産をしたという報告はないではないが、奇形をおこさないという意見のほうがおおい。

妊婦の血液検査をしたところ、**B型肝炎**の抗原(HBs-Ag)がみつかつて、**B型肝炎**の保因者だといわれることがある。つづけて肝機能の検査をして肝炎の有無をしらべることになる。肝炎があるとわかったら、医師によつては妊娠を中絶するようにいうかもしれない。肝炎の程度によつては妊娠をつづ



けるようにいう医師もあろう。肝炎があつても胎児に奇形をおこすことはないが、赤ちゃんに肝炎ウイルスをうつすことは、かんがえられる。肝機能は正常だが、血液にHBe抗原があるとわかったら、生まれる子が肝炎の抗原をもつ保因者になるのをふせぐため、**B型肝炎ワクチン**を接種する。

ウイルスではないが、**梅毒**の**トレポネーマ**が妊娠中に侵入することはある。妊娠の診断がついたときに血液の検査をして梅毒の反応が陰性であっても、その後に感染することはありうる。ほとんど全部が性の交渉によつてうつるのだから、配偶者が不品行のときは、妊娠中に感染することもある。ふつう自覚症状はないが、感染後2〜3週たてば血清反応が陽性になる。陽性の場合はずぐに治療をする。治療すれば胎児に先天梅毒のおこるのをふせげる。梅毒の検査では、血清反応に「生物学的偽陽性」のあることを知らないと家庭争議になる(624梅毒)。TPHA(トレポネーマ赤血球凝集法)テストかFTA(蛍光抗体法)テストでたしかめる。